

Jak dzieciństwo wpływa na dorosłość po przemocy psychicznej i fizycznej ze strony rodziców

Przemoc psychiczna i fizyczna ze strony rodziców zwiększa ryzyko szerokiego spektrum problemów w dorosłości: depresji, zaburzeń lękowych, PTSD i cPTSD, trudności w regulacji emocji, problemów relacyjnych, zaburzeń osobowości, gorszego zdrowia somatycznego oraz większej podatności na ponowną wiktyimizację. Zależność ma charakter dawka–reakcja: im więcej niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa i im bardziej są one przewlekłe, tym większe przeciętne ryzyko późniejszych zaburzeń. Związek ten utrzymuje się także po częściowej kontroli współdzielonych czynników rodzinnych i genetycznych. [1]

Przemoc psychiczna i fizyczna częściowo nakładają się na siebie, ale nie są klinicznie identyczne. Przemoc psychiczna częściej wiąże się z trwałym wstydem, negatywnym obrazem siebie, samokrytycyzmem, rozszczepieniem poczucia tożsamości i gorszym dobrostanem w bliskich relacjach. Przemoc fizyczna dodaje do tego bezpośredni komponent zagrożenia ciała, bólu i pobudzenia obronnego; częściej wiąże się z problemami eksternalizacyjnymi, impulsywnością, agresją i utrwalonym odczytywaniem konfliktu jako niebezpieczeństwa. W praktyce klinicznej oba typy przemocy często współwystępują, a najcięższy obraz daje trauma relacyjna od obojga rodziców lub sytuacja, w której jedno z rodziców krzywdzi, a drugie nie chroni. [2]

Opisane przez Ciebie zjawiska — chęć bycia samej, lęk przed rozpadem związku, trwanie uczuć podczas kłótni, wycofywanie się lub zrywanie relacji — bardzo dobrze mieszczą się w obrazie wysokiego lęku przywiązaniowego i wysokiego unikania bliskości, czasem z domieszką dezorganizacji i dysocjacji. W takim układzie jedna część osoby silnie pragnie bliskości i boi się porzucenia, a inna traktuje bliskość jako źródło zagrożenia, przeciążenia lub utraty kontroli. Konflikt w związku uruchamia wtedy nie tylko „zwykły stres”, ale cały dawny system alarmowy. [3]

Najlepiej potwierdzone interwencje to psychoterapie skoncentrowane na traumie: trauma-focused CBT, cognitive processing therapy, prolonged exposure, cognitive therapy for PTSD, narrative exposure therapy oraz EMDR. W traumie złożonej, zwłaszcza przy dużej dysregulacji emocji i problemach relacyjnych, przydatne bywają podejścia fazowe, STAIR, terapia schematów, praca nad mentalizacją oraz — na późniejszym etapie — tera-

pie par oparte na przywiązaniu. Farmakoterapia jest opcją pomocniczą, a nie „naprawą przywiązania”; najczęściej rozważa się SSRI lub wenlafaksynę, a przy koszmarach po-urazowych czasem prazosynę. Benzodiazepin nie zaleca się do leczenia PTSD. [4]

Najważniejszy wniosek praktyczny brzmi: przejście od lękowo-unikowego funkcjonowania do zdolności tworzenia zdrowego związku zwykle nie polega na „zmuszaniu się do bliższości”, lecz na sekwencji etapów — bezpieczeństwo, regulacja, rozpoznanie schematów, przetworzenie traumy, odbudowa spójnego Ja, trening granic i wybór relacji zgodnych z wartościami. Pierwsze istotne zmiany objawowe mogą pojawić się po kilku miesiącach uporządkowanej terapii, ale głębsza zmiana stylu relacyjnego i tożsamości częściej wymaga pracy liczonej w wielu miesiącach, a czasem w 1–2 latach. [5]

Jak przemoc rodzicielska zapisuje się w dorosłości

Dziecko nie uczy się wyłącznie „jakie są relacje”; uczy się także „kim jestem”, „czy moje emocje mają sens”, „czy mogę liczyć na pomoc” i „czy moje ciało jest bezpieczne”. Jeśli źródłem zagrożenia są rodzice, czyli osoby, od których biologicznie i psychicznie zależy przetrwanie, uraz ma charakter relacyjny: uderza nie tylko w poczucie bezpieczeństwa, lecz także w rozwój samoregulacji, obrazu siebie, mentalizacji i zdolności tworzenia stabilnych więzi. W polskiej literaturze taki obraz bywa opisywany jako trauma relacyjna, wykraczająca poza klasyczne objawy PTSD i obejmująca także dysocjację, somatyzację oraz dysregulację afektu. [6]

Różnica między przemocą psychiczną a fizyczną jest realna, choć nie absolutna. Przemoc psychiczna — upokarzanie, odrzucanie, straszenie, dewaluacja, gaslighting, emocjonalne ignorowanie lub karanie za potrzeby — szczególnie silnie formuje trwałe przekonania typu „jestem nieważna”, „jestem za dużo”, „moje uczucia są niebezpieczne”, „bliskość kończy się zawstydzeniem”. Metaanalizy wskazują, że psychiczne maltretowanie w dzieciństwie jest związane z gorszym zdrowiem psychicznym w dorosłości, a emocjonalne nadużycia i zaniedbanie wydają się szczególnie istotne dla późniejszej depresji, psychopatologii i problemów w relacjach romantycznych. [7]

Przemoc fizyczna wnosi dodatkowo doświadczenie nagłego zagrożenia ciała, bólu i nieprzewidywalności. Długofalowo częściej wiąże się z nadmierną czujnością, szybszym przechodzeniem w reakcję walcz/uciekaj/zastygnij, a także z problemami eksternalizacyjnymi i trudnościami w rozumieniu konfliktu inaczej niż jako starcia sił. Współczesne metaanalizy pokazują, że fizyczne karanie i agresja fizyczna korelują z gorszym zdrowiem psychicznym, gorszymi relacjami rodzic-dziecko, większym używaniem substan-

cji, słabszym rozwojem społeczno-emocjonalnym i nasileniem zachowań eksternalizacyjnych. [8]

Wpływ obojga rodziców nie jest po prostu „sumą dwóch urazów”; często daje jakościowo cięższy wzorzec. Jeśli ojciec krzywdzi, a matka nie chroni, dziecko może internalizować jednocześnie dwa modele: „mężczyzna/bliskość to zagrożenie” oraz „nawet gdy cierpię, nikt mnie nie uratuje”. Jeśli oboje rodzice są źródłem przemocy, wzrasta skumulowane obciążenie ACEs, a literatura konsekwentnie pokazuje, że wielość i przewlekłość takich doświadczeń zwiększa ryzyko przyszłych zaburzeń. Dodatkowo dzieci żyjące w domu z przemocą między dorosłymi są bardziej narażone także na własną wiktymizację emocjonalną, fizyczną i seksualną. [9]

To ważne klinicznie: nie każda osoba po przemocy rozwija pełnoobjawowe PTSD, ale wiele osób będzie miało obraz bardziej zbliżony do cPTSD lub szerzej pojętej traumy relacyjnej. ICD-11 opisuje cPTSD jako PTSD plus trwałe trudności w regulacji afektu, negatywny obraz siebie oraz utrwalone problemy w relacjach i odczuwaniu bliskości — dokładnie ten profil, który często pozostaje po długotrwałej przemocy rodzicielskiej. [10]

Mechanizmy przywiązania, traumy i schematów

W modelach współczesnego przywiązania dorosłych kluczowe są dwa wymiary: lęk przed opuszczeniem i unikanie bliskości. Wysoki lęk oznacza nadwrażliwość na sygnały odrzucenia, silne pragnienie upewniania się, szukanie potwierdzeń, katastrofizację wobec dystansu i skłonność do ruminacji po konflikcie. Wysokie unikanie oznacza hamowanie ekspresji emocji, dystansowanie się od zależności, przecenianie samowystarczalności, tłumienie potrzeb więzi i uruchamianie „dezaktywujących” strategii pod wpływem bliskości lub konfliktu. Przywiązanie bezpieczne polega natomiast na zdolności do łączenia bliskości z autonomią. [11]

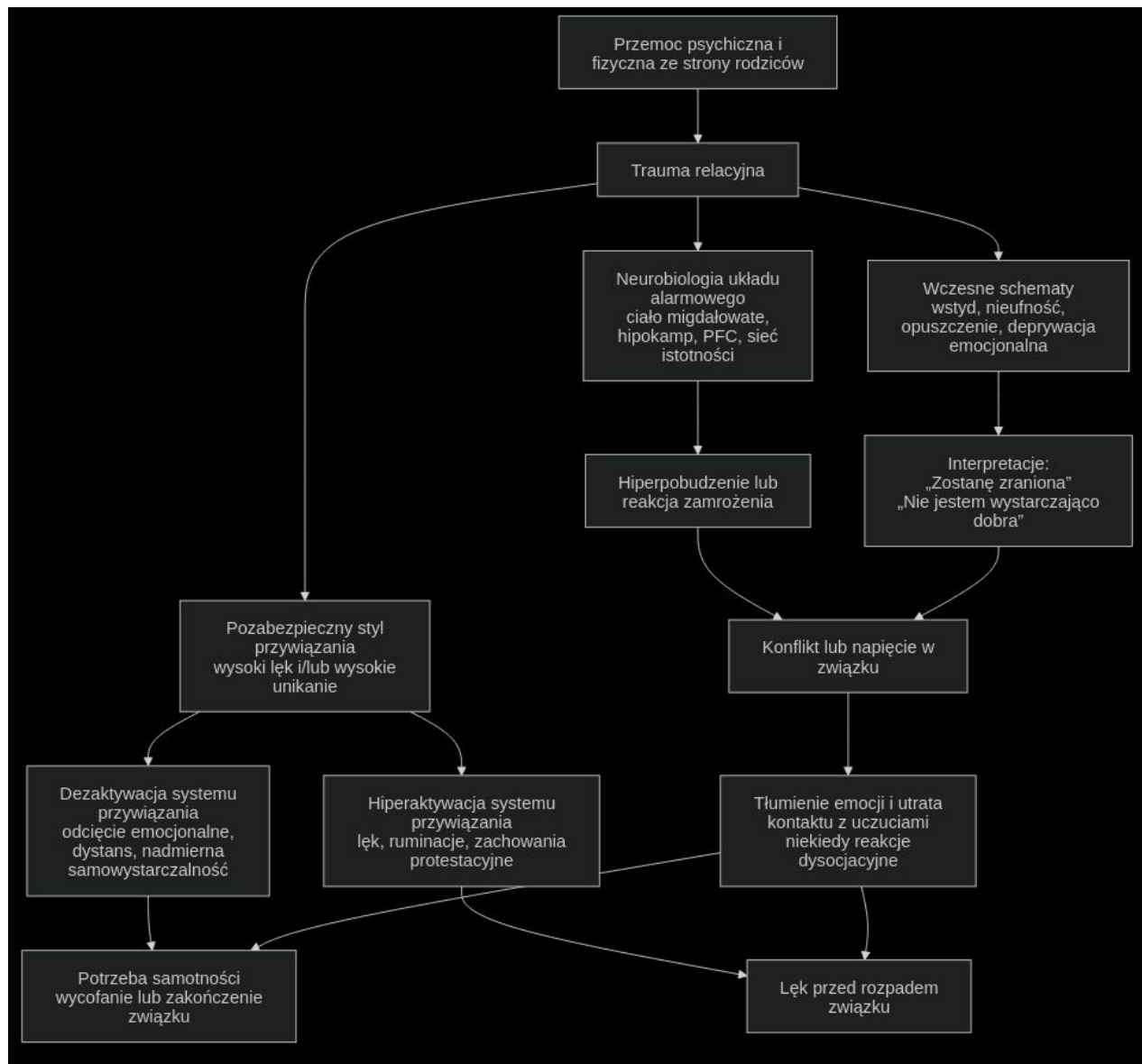
Dlatego osoba z profilem lękowo-unikowym może jednocześnie bardzo bać się samotności i bardzo potrzebować samotności. To nie jest sprzeczność charakteru, lecz konflikt dwóch strategii obronnych: hiperaktywacji systemu przywiązania i jego dezaktywacji. W codziennym życiu może to wyglądać tak: po oddaleniu partnera pojawia się panika, rumination i wysiłek odzyskania więzi; po zbyt dużej bliskości lub po kłótni pojawia się emocjonalne odcięcie, znieczulenie, utrata dostępu do czułości albo impuls „muszę wyjść/zerwać”. [12]

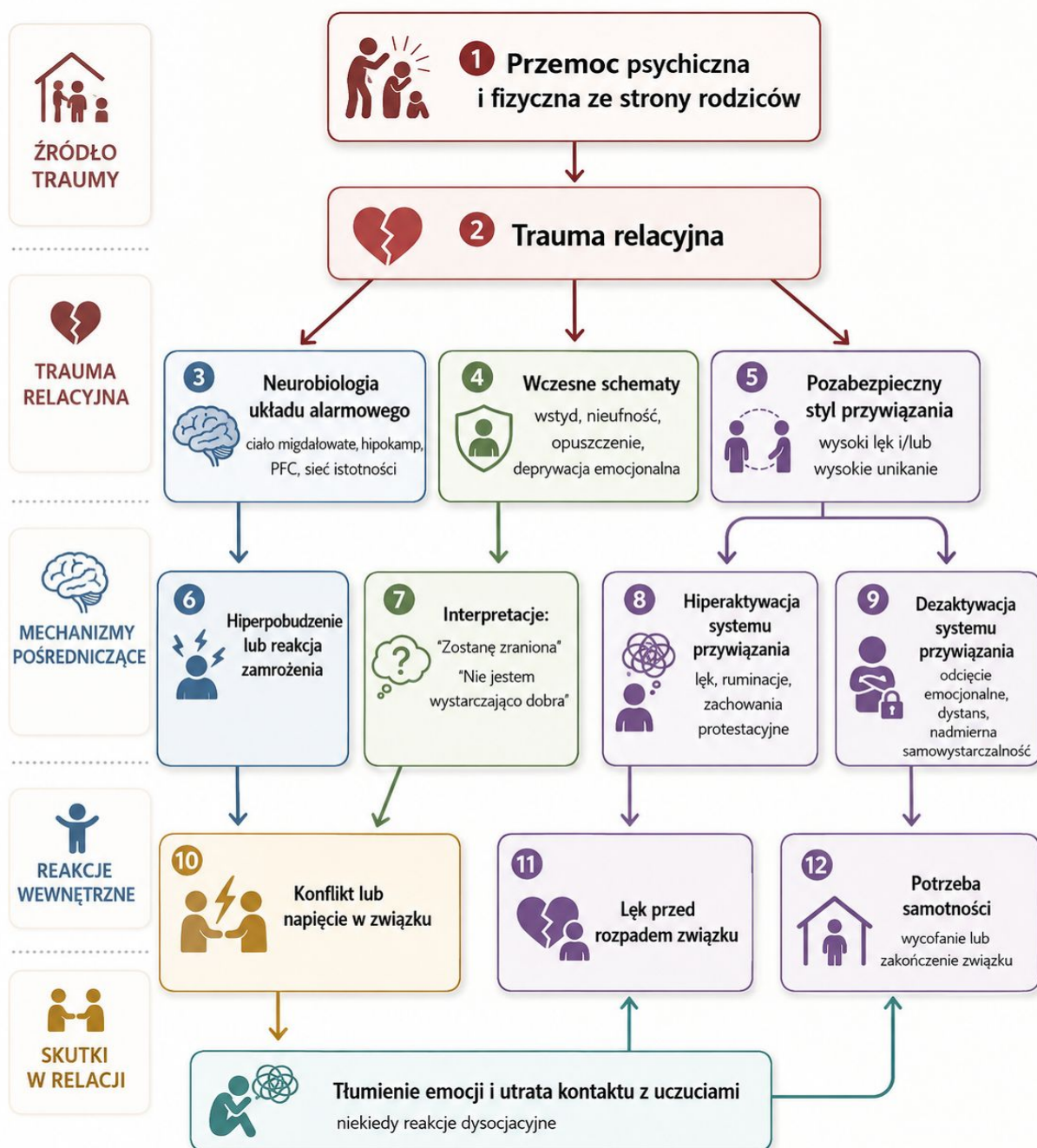
Utrata uczuć podczas kłótni nie musi oznaczać, że uczucia „naprawdę zniknęły”. Często jest to efekt tłumienia ekspresji, przeciążenia alarmowego albo dysocjacyjnego

odłączenia. Badania nad konfliktem partnerskim pokazują, że postrzeganie mniejszej akceptacji podczas sporu wiąże się z większą ekspresywną supresją, a ona z kolei pogarsza funkcjonowanie relacyjne. Przy traumie relacyjnej dochodzi do tego zjawisko dysocjacji i „shut-down”, które mogą chwilowo odcinać dostęp do uczuć, pamięci autobiograficznej, potrzeb i poczucia ciągłości Ja. [13]

Neurobiologicznie wczesna trauma wiąże się z trwałymi zmianami w układach stresu i regulacji emocji. Najczęściej opisywane są zmiany w obwodach obejmujących ciało migdałowe, hipokamp i korę przedczołową oraz zaburzenia łączności w sieciach odpowiedzialnych za reaktywność emocjonalną, regulację, uczenie się i wykrywanie bodźców istotnych. W praktyce klinicznej przekłada się to na szybsze uruchamianie alarmu, gorsze gaszenie lęku, zawężanie pola uwagi pod wpływem zagrożenia i trudniejszy dostęp do refleksji w momentach pobudzenia. To nie jest „wina słabego charakteru”, lecz biologiczne osadzenie doświadczenia. [14]

Na poziomie poznawczym trauma rodzicielska często tworzy wczesne nieadaptacyjne schematy: opuszczenia, nieufności/skrzywdzenia, wadliwości/wstydu, deprywacji emocjonalnej, podporządkowania czy nieustępliwych standardów. Badania nad terapią schematów pokazują, że wczesne doświadczenia przemocy i zaniedbania są powiązane z nasileniem tych schematów w dorosłości, a szczególnie istotne okazują się emocjonalne formy krzywdzenia. Schematy te potem filtrują wybory partnerów, interpretację konfliktów i decyzje rozstaniowe. [15]





Powyższy schemat syntetyzuje dane z badań nad neurobiologią maltretowania, emocjonalną regulacją przywiązaniową i traumą relacyjną. [16]

Jak odróżniać autentyczne ja od wzorców potraumatycznych

Nie istnieje jedno laboratoryjne kryterium odróżniające „prawdziwą cechę” od „schematu po traumie”, ale istnieją użyteczne kryteria robocze. Najbardziej praktyczne pytanie brzmi nie „czy to jestem ja?”, lecz „czy ta reakcja jest elastyczna, zgodna z moimi wartościami i stabilna także wtedy, gdy mój układ nerwowy jest spokojny?”. Badania nad samospójnością, mentalizacją i przywiązaniem sugerują, że trauma dziecięca wiąże się z mniejszą klarownością obrazu siebie, gorszą refleksyjnością i większym ryzykiem podejmowania decyzji pod wpływem stanu alarmowego zamiast spójnej tożsamości. [17]

W praktyce klinicznej bardziej autentyczne decyzje mają zwykle cztery cechy. Po pierwsze, są względnie stałe także po regulacji pobudzenia; po drugie, zwiększają sprawczość bez zawężania życia; po trzecie, nie służą wyłącznie natychmiastowej redukcji wstydu, lęku lub napięcia; po czwarte, pozostają zgodne z długoterminowymi wartościami, a nie tylko z chwilową potrzebą ucieczki. To jest raczej heurystyka integrująca podejście oparte na schematach, mentalizacji i ACT niż osobny, zwalidowany test. [18]

Użyteczne są trzy proste ćwiczenia samomonitorowania. Pierwsze to **dziennik wyzwalacza**: zapisujesz sytuację, automatyczną myśl, emocję, impuls do działania i to, co zrobiłaś. Drugie to **podwójny zapis stanu**: tę samą decyzję opisujesz raz „w szczycie pobudzenia”, a drugi raz po 20–30 minutach regulacji oddechem, ruchem lub uziemieniem; jeśli decyzja dramatycznie się zmienia, duży udział ma stan, nie wartość. Trzecie to **test wartości**: pytasz, czy dana decyzja przybliży Cię do relacji, w której jest wzajemność, szacunek, przewidywalność i możliwość naprawy konfliktu. Techniki te są zgodne z metodami stosowanymi w CBT, terapii schematów, ACT i podejściach mentalizacyjnych; baza dowodowa jest najsilniejsza dla całych protokołów terapeutycznych, a słabsza dla pojedynczych mikroćwiczeń wykonywanych samodzielnie. [19]

Szczególnie ważne jest rozpoznawanie własnych „fałszywych sygnałów zerwania”. Do takich sygnałów należą: nagły spadek ciepła po konflikcie, przekonanie „już nic nie czuję” pojawiające się wyłącznie w stanie przeciążenia, automatyczne „muszę być sama”, ostry wstyd po potrzebie bliskości, interpretowanie drobnego dystansu jako zapowiedzi porzucenia oraz odruch zrywania relacji po to, by wyprzedzić ból rozpadu. To nie dowodzi, że relacja jest dobra ani że trzeba zostać; pokazuje tylko, że ocena relacji bez regulacji pobudzenia bywa mało wiarygodna. [20]

Interwencje o najlepszym poparciu empirycznym

Najmocniejsze dowody dla dorosłych z PTSD i objawami potraumatycznymi mają terapie trauma-focused CBT, cognitive processing therapy, cognitive therapy for PTSD, prolonged exposure, narrative exposure therapy oraz EMDR. NICE zaleca dla dorosłych po ponad miesiącu od traumy przede wszystkim indywidualną terapię trauma-focused CBT, a EMDR jako terapię oferowaną po ponad trzech miesiącach przy traumie niebojowej; oba protokoły są zwykle planowane na około 8–12 sesji, ale wytyczne wyraźnie zaznaczają, że przy wielu traumach potrzeba zwykle więcej czasu. Polska literatura przeglądowa jest zgodna z tym obrazem: najlepsze dowody dotyczą terapii opartych na ekspozycji i EMDR. [21]

W traumie złożonej po przemocy rodzicielskiej warto myśleć nie tylko kategorią „objawy PTSD”, ale także regulacji emocji, wstydu, złości, granic, przywiązania i schematów. Tutaj przydatne bywają modele fazowe, np. STAIR z późniejszym przetwarzaniem traumy. RCT u kobiet z PTSD związanym z przemocą w dzieciństwie pokazał, że sekwencja treningu regulacji i umiejętności interpersonalnych przed ekspozycją dawała więcej trwałych remisji niż sama ekspozycja lub same umiejętności, ale inne badania wskazują, że natychmiastowa terapia trauma-focused także może być dobrze tolerowana i skuteczna. Najuczciwszy wniosek brzmi więc: fazowanie jest użyteczne wtedy, gdy dysregulacja, dysocjacja lub chaos relacyjny są główną przeszkodą, lecz nie należy stabilizacji przeciągać w nieskończoność. [22]

Terapia schematów ma sens szczególnie wtedy, gdy dominują przewlekły wstyd, poczucie wadliwości, wybieranie raniących partnerów, silne tryby „odłączonego obrońcy”, „uległego dziecka” lub „karzącego rodzica”. Systematyczne przeglądy pokazują, że terapia schematów prowadzi do poprawy objawów i samych schematów, choć duża część mocnych danych pochodzi z zaburzeń osobowości, a nie wyłącznie z cPTSD. W praktyce jest to często dobra metoda dla osób, które rozumieją już swoje objawy traumatyczne, ale nadal żyją według dawnych wzorców relacyjnych. [23]

Podjęcia skoncentrowane na emocjach i przywiązaniu mają mniej jednorodną bazę dowodową niż TF-CBT czy EMDR, ale są istotne na etapie odbudowy więzi. Meta-analizy EFT dla par wskazują na poprawę satysfakcji i utrzymywanie zmian po leczeniu, a przeglądy terapii par/familijnych dla PTSD sugerują korzyści dla nasilenia PTSD i niekiedy dla relacji, choć jakość dowodów jest niższa niż dla terapii indywidualnych. Dlatego terapia par jest zwykle najlepsza wtedy, gdy podstawowe bezpieczeństwo i zdolność do samoregulacji zostały już zbudowane. [24]

„Praca z ciałem” ma sens jako **uzupełnienie**, nie substytut leczenia głównego. Metaanalizy sugerują, że joga, interwencje mindfulness i niektóre body- and movement-oriented interventions mogą redukować objawy PTSD i depresji, ale jakość badań jest bardziej zróżnicowana niż w przypadku terapii traumatycznych, dlatego wytyczne traktują te metody ostrożniej. Najrozsądniejsze miejsce dla nich to: poprawa interocepcji, obniżenie pobudzenia, nauka samouspokajania i odzyskiwanie bezpiecznego kontaktu z ciałem. [25]

Farmakoterapię warto rozważyć wtedy, gdy objawy są nasilone, osoba preferuje leczenie farmakologiczne, depresja lub lęk są na tyle ciężkie, że utrudniają psychoterapię, występują poważne zaburzenia snu albo gdy dostęp do terapii jest odroczony. NICE wskazuje SSRI, zwłaszcza sertralinę, oraz wenlafaksynę jako opcje dla dorosłych z PTSD, jeśli preferują leczenie farmakologiczne. Wytyczne VA/DoD rekomendują paroksetynę, sertralinę lub wenlafaksynę; prazosyna może pomóc w koszmarach pourazowych. Jednocześnie VA/DoD mocno odradza benzodiazepiny w PTSD z powodu braku długoterminowych korzyści i ryzyk. [26]

Grupy wsparcia i terapia grupowa mogą być wartościowe, ale trzeba rozróżnić dwa poziomy dowodów. Dla **ustrukturyzowanej psychoterapii grupowej** istnieją metaanalizy wskazujące na redukcję objawów PTSD. Dla **peer support** dowody są bardziej jakościowe i nierówne metodologicznie, ale sugerują spadek izolacji, lepsze rozumienie własnych reakcji i większe poczucie wspólnoty. Najlepiej traktować grupę wsparcia jako dodatek do indywidualnej terapii, zwłaszcza jeśli dominuje wstyd i poczucie „tylko ja tak mam”. [27]

Plan przejścia od lękowo-unikowego funkcjonowania do zdolności tworzenia zdrowego związku

Poniższy plan jest syntezą wytycznych i badań. Nie zakłada liniowego „wyleczenia”, tylko stopniowe przechodzenie od reaktywności do większej zdolności wyboru. Orientacyjne ramy czasowe wynikają z długości typowych protokołów PTSD, faktu że przy wielu traumach potrzeba więcej sesji, oraz z badań pokazujących, że zmiana bezpieczeństwa przywiązaniowego zwykle zachodzi wolniej niż redukcja samych objawów. [28]

Obszar	Typowe skutki	Dominujący mechanizm	Interwencje o najlepszym oparciu	Oczekiwane rezultaty	Orientacyjny czas
Przemoc psychiczna	wstyd, samokrytycyzm, negatywny obraz siebie,	schematy wadliwości, opuszczenia, depriwacji;	terapia schematów, TF-CBT/CPT, EMDR; trening mentalizacji	mniej automatycznego wstydu, lepsza spójność Ja, mniej decyzji z pozycji „jestem beznadziejna”	zwykle miesiące; przy złożonych schematach często 6–

Obszar	Typowe skutki	Dominujący mechanizm	Interwencje o najlepszym oparciu	Oczekiwane rezultaty	Orientacyjny czas
	trudność w czuciu własnych potrzeb, problemy z bliskością [29]	spadek self-concept clarity i mentalizacji [30]	jako komponent [31]	[32]	18 mies. jako synteza badań i wytycznych [33]
Przemoc fizyczna	nadmierna czujność, szybka mobilizacja obronna, impulsywność, czasem agresja lub gwałtowne wycofanie [34]	uczenie alarmowe, ciało jako miejsce zagrożenia, przewidywanie bólu w konflikcie [35]	PE/CPT/CT-PTSD/EMDR; interwencje regulacyjne i praca z ciałem jako dodatki [36]	spadek reaktywności, lepsze odróżnianie konfliktu od przemocy, większa tolerancja napięcia [37]	pierwsza poprawa objawów często 8–12+ sesji; dłużej przy wielokrotnej traumie [38]
Trauma od obojga rodziców	cPTSD, problemy z relacjami, poczucie że bliskość i zależność są niebezpieczne, trudność w zaufaniu komukolwiek [39]	skumulowane ACEs, brak bezpiecznej figury regulacyjnej, dezorganizacja przywiązania [40]	często model fazowy: bezpieczeństwo i regulacja → przetwarzanie traumy → integracja relacyjna [41]	mniej chaosu relacyjnego, wzrost zaufania do siebie i innych, większa pojemność na bliskość bez paniki lub odcięcia [42]	częściej dłuższa praca; orientacyjnie 9–24 mies., czasem więcej [33]
Wysoki lęk przywiązaniowy	obawa przed rozpadem związku, nadinterpretacja dystansu, ruminalacje, „protest” po oddaleniu partnera [43]	hiperaktywacja systemu przywiązania i skupienie uwagi na sygnałach odrzucenia [44]	CBT/CPT, regulacja emocji, praca nad schematem opuszczenia, ograniczanie reassurance-seeking; później terapia par jeśli relacja jest bezpieczna [45]	spadek paniki separacyjnej, mniej ruminalacji, większa zdolność do prośbienia o bliskość wprost [46]	zwykle 3–9 mies. na pierwszą stabilizację; głębsza zmiana dłużej [47]
Wysokie unikanie przywiązaniowe	chęć bycia samej, wycofanie po konflikcie, nadmierna samowystarczalność, zrywanie relacji dla odzyskania kontroli [48]	dezaktywacja systemu przywiązania, supresja emocji, dystans jako regulator przeciążenia [49]	terapia ukierunkowana na emocje i przywiązanie, terapia schematów, stopniowe ćwiczenia ujawniania potrzeb i granic bez przeciążenia [50]	lepszy kontakt z uczuciami bez zalanania, większa zdolność pozostania w relacji po sporze, mniej automatycznych zerwań [51]	zwykle wolniej niż przy samym lęku; często 6–18 mies. [52]
Shut-down i utrata uczuć	odrętwienie, „nic nie czuję”	dysocjacja lub obronne odłączenie	regulacja przed rozmową, przerwy naprawcze	szybszy powrót do kontaktu ze sobą, mniej „fałszywych”	tygodnie do miesięcy dla

Obszar	Typowe skutki	Dominujący mechanizm	Interwencje o najlepszym oparciu	Oczekiwane rezultaty	Orientacyjny czas
w kłótni	ję”, pustka, chęć zniknięcia, czasem fragmentaryczna pamięć rozmowy [53]	czenie przy przeciążeniu układu nerwowego [54]	cze, EMDR/TF-CBT przy traumie, trening interocepcji i mindfulness jako dodatki [55]	szywych decyzji końcowych” podejmowanych w shut-downie [56]	poprawy regulacji; trauma processing zwykle dłużej [38]
Psychoterapia indywidualna	objawy PTSD/cPTSD, schematy, samoocena, relacje [57]	zmiana pamięci traumy, znaczenia, unikania i regulacji emocji [58]	TF-CBT/CPT/PE/CT-PTSD/NET, EMDR; adaptacja do wielu traum, dysocjacji i potrzeb relacyjnych [59]	redukcja objawów, odbudowa funkcjonowania, poprawa zdolności do bliskości i autonomii [60]	typowo 8–12+ sesji; więcej przy złożonej traumie [38]
Metody uzupełniające	napięcie ciała, bezsenność, odcięcie od sygnałów z ciała, izolacja [61]	zaburzona interocepcja i utrwalone pobudzenie lub odrętwienie [62]	joga, mindfulness, ćwiczenia, grupa wsparcia; ewentualnie CBT-I przy bezsenności [63]	poprawa uziemienia, snu, tolerancji emocji i poczucia wspólnoty; zwykle efekt pomocniczy, nie wystarczający samodzielnie [64]	8–12 tyg. dla pierwszych zmian; jako dodatek długofalowo [65]

Plan krok po kroku można ująć następująco. **Etap pierwszy** to bezpieczeństwo i diagnoza robocza: ocena aktualnego zagrożenia, samouszkodzeń, uzależnień, przemocy w bieżących relacjach, nasilenia PTSD/cPTSD, depresji, lęku, dysocjacji i snu. Jeśli depresja jest tak ciężka, że blokuje terapię urazu albo pojawia się ryzyko zrobienia sobie krzywdy, najpierw trzeba ustabilizować ten poziom. NICE podkreśla też, że przy cPTSD trzeba doliczyć czas na budowanie zaufania, rozwiązanie barier angażowania się w terapię i zaplanowanie wsparcia po zakończeniu leczenia. [66]

Etap drugi to regulacja i mapa wzorców. Celem nie jest „nauczyć się nie czuć”, ale zwiększyć tolerancję na uczucia bez natychmiastowej ucieczki albo zalanania. Tu zwykle pracuje się nad nazwaniem triggerów, sygnałów z ciała, sekwencji konfliktowej, różnicą między potrzebą a impulsem oraz nad rozpoznaniem trybów/schematów. Jeśli dominują koszmary, ciężki bezsenność, silny lęk lub depresja, równolegle można rozważyć leczenie wspomagające; przy insomnii VA/DoD rekomenduje CBT-I, a przy samych koszmarach rozważa prazosynę. [67]

Etap trzeci to przetwarzanie traumy. Dla części osób będzie to EMDR, dla części CPT, PE, CT-PTSD albo inna manualizowana terapia traumatyczna. Kluczowe jest tu przepisanie znaczeń: „to, że byłam źle traktowana, nie znaczy, że byłam złą”; „konflikt nie równa się zagrożeniu życia”; „potrzeba bliskości nie jest słabością”. Jeśli terapia zatrzymuje się miesiącami wyłącznie na stabilizacji bez dotykania wspomnień, znaczeń i uni-

kania, warto sprawdzić, czy nie utrwała się terapeutycznie usankcjonowana forma ucieczki. [68]

Etap czwarty to integracja tożsamości i przywiązania. Tutaj pojawia się pytanie „kim jestem, kiedy nie rządzi mną dawny alarm?”. Praca obejmuje odróżnianie autentycznych preferencji od reakcji obronnych, tolerowanie ambiwalencji, ćwiczenie granic bez zrywania więzi oraz budowanie obrazu siebie, który nie opiera się na wstydzie i przewidywanym odrzuceniu. Zmiana przywiązania w psychoterapii jest możliwa; metaanalizy i badania procesowe sugerują wzrost bezpieczeństwa przywiązaniowego i spadek lęku po skutecznej terapii. [69]

Etap piąty to trening zdrowego związku. W praktyce oznacza to: wolniejsze tempo wchodzenia w bliskość, obserwowanie zgodności słów i czynów partnera, wprowadzanie napraw po konflikcie, odkładanie decyzji o zerwaniu do momentu wyregulowania, jawne mówienie o potrzebach i granicach, uczenie się bycia w relacji bez nadmonitorowania i bez odcinania. Jeśli relacja jest bezpieczna, a problemem pozostają wzorce przywiązaniowe i rany relacyjne, terapia par może być bardzo użyteczna. [70]

Do monitorowania postępów warto używać kilku prostych narzędzi, ale zawsze w tym samym rytmie i z omówieniem wyników z terapeutą. Do PTSD: **PC-PTSD-5** jako krótki screening i **PCL-5** do śledzenia zmian objawów. Do lęku i depresji: **GAD-7**, **PHQ-9** lub łączny **PHQ-ADS**. Do wzorców relacyjnych: **ECR-R** albo **ECR-RS**. Do mentalizacji: **MentS**. Jeśli występują epizody odcięcia, amnezji, „nierealności”, przydatny bywa także kwestionariusz dysocjacji. Najważniejsze nie jest pojedyncze badanie, tylko trend: czy maleje reaktivność, unikanie, ruminalność i liczba decyzji podejmowanych w stanie alarmowym. [71]

Najczęstsze przeszkody to wstyd, unikanie, zrywanie terapii przy pierwszym dotknięciu bólu, idealizowanie samowystarczalności, niski dostęp do specjalistów i obawa przed stygmatyzacją. W metaanalizach drop-out z terapii PTSD jest istotny, zwłaszcza w terapiach trauma-focused, a sojusz terapeutyczny konsekwentnie przewiduje lepszy wynik. To znaczy, że dobór terapeuty, możliwość omawiania oporu, przewidywalność sesji i aktywne monitorowanie przeciążenia są równie ważne jak sama technika. Jeśli barierą jest dostęp, teleterapia dla PTSD ma wyniki zbliżone do pracy twarzą w twarz. [72]



Ta oś czasu jest z konieczności orientacyjna. Wytyczne PTSD mówią o 8–12 sesjach dla wielu protokołów, ale jednocześnie wyraźnie zaznaczają potrzebę większej liczby sesji przy wielokrotnych traumach i cPTSD; badania nad zmianą przywiązania pokazują zaś, że głębsza reorganizacja relacyjna bywa wolniejsza niż redukcja objawów. [28]

Jeśli miałbym sprowadzić cały raport do jednego praktycznego zdania, brzmiałoby ono tak: **Twoje obecne reakcje w relacjach nie są dowodem „wadliwej osobowości”, lecz zrozumiałymi adaptacjami do wczesnego zagrożenia; zdrowienie polega na tym, by przestały być jedyną dostępną strategią.** W dobrze prowadzonej terapii celem nie jest usunięcie potrzeby bliskości ani wymuszenie zależności, tylko zbudowanie zdolności do bliskości bez paniki i autonomii bez odcięcia. [73]

Bibliografia

[1] The long-term health consequences of child physical ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23209385/?utm_source=chatgpt.com

[2] Doświadczanie przemocy w dzieciństwie – skutki w życiu dorosłym

<https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/download/827/675>

[3] [11] [48] psychiatriapolska.pl

<https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-131623-80568?filename=Characteristics+of.pdf>

[4] [5] [10] [21] [26] [28] [33] [36] [38] [47] [55] [58] [59] [66] [68] Recommendations | Post-traumatic stress disorder | Guidance | NICE

<https://www.nice.org.uk/guidance/ng116/chapter/recommendations>

[6] [39] [53] [54] [57] [73] psychiatriapolska.pl

<https://www.psychiatriapolska.pl/pdf-156722-112492?filename=112492.pdf>

[7] [29] The Impact of Childhood Psychological Maltreatment on ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36123796/?utm_source=chatgpt.com

[8] [34] Physical punishment and lifelong outcomes in low ... - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40325199/?utm_source=chatgpt.com

[9] [40] The effect of multiple adverse childhood experiences on ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29253477/?utm_source=chatgpt.com

[12] [43] [49] Attachment orientations and emotion regulation

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29494853/?utm_source=chatgpt.com

[13] [20] Perceived regard, expressive suppression during conflict, ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29927283/?utm_source=chatgpt.com

[14] [16] [35] Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26831814/?utm_source=chatgpt.com

[15] [30] Adverse childhood experiences and early maladaptive ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33270299/?utm_source=chatgpt.com

[17] The relationship with self-concept clarity

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40020289/?utm_source=chatgpt.com

[18] [19] [45] [67] Emotion Regulation in Schema Therapy and Dialectical ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27683567/?utm_source=chatgpt.com

[22] [41] Treatment for PTSD related to childhood abuse - PubMed - NIH

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20595411/?utm_source=chatgpt.com

[23] [31] [32] The effectiveness of schema therapy for patients with ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34296767/?utm_source=chatgpt.com

[24] [50] [70] Emotionally Focused Couples Therapy: A Systematic ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30605013/?utm_source=chatgpt.com

[25] [63] [65] Efficacy of yoga for posttraumatic stress disorder - PubMed - NIH

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39191128/?utm_source=chatgpt.com

[27] Efficacy of group psychotherapy for posttraumatic stress ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29179647/?utm_source=chatgpt.com

[37] [60] Psychological therapies for post-traumatic stress disorder ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32284821/?utm_source=chatgpt.com

[42] An Examination of the Influence of a Sequential Treatment ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22550033/?utm_source=chatgpt.com

[44] Adult attachment and the perception of emotional ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16787432/?utm_source=chatgpt.com

[46] [52] [69] Changes in attachment representations during ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24559454/?utm_source=chatgpt.com

[51] Two-Year Follow-up Outcomes in Emotionally Focused ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27997704/?utm_source=chatgpt.com

[56] [62] Interoceptive Awareness Skills for Emotion Regulation - PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29892247/?utm_source=chatgpt.com

[61] Review of somatic symptoms in post-traumatic stress disorder

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23383670/?utm_source=chatgpt.com

[64] [71] VA/DoD Clinical Practice Guideline for Management of Posttraumatic Stress Disorder and Acute Stress Disorder

<https://www.healthquality.va.gov/HEALTHQUALITY/guidelines/MH/ptsd/VA-DoD-CPG-PTSD-Full-CPG-Edited-111624-V5-81825.pdf>

[72] Dropout from psychological therapies for post-traumatic ...

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32284816/?utm_source=chatgpt.com